

**ДОДАТОК І**  
**ОГЛЯД ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКТУ**

▼ Цей лікарський засіб підлягає додатковому моніторингу, що прискорить виявлення нової інформації про його безпеку. Просимо медичних спеціалістів повідомляти про будь-які підозрювані побічні реакції. В розділі 4.8 описано, як повідомляти про побічні реакції.

## 1. НАЗВА ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ

SIILTIVCY (0,5 мікрограма + 0,5 мікрограма)/мл розчину для ін'єкцій  
Антигени, отримані з *Mycobacterium tuberculosis* (rdESAT-6 та rCFP-10)

## 2. ЯКІСНИЙ ТА КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД

Одна доза (0,1 мл) препарату містить 0,05 мкг rdESAT-6\* та 0,05 мкг rCFP-10\*\*.

\* Рекомбінований димер раннього секреторного антигенного білка *Mycobacterium tuberculosis*<sup>1</sup>

\*\* Рекомбінований білок фільтрату культурального середовища *Mycobacterium tuberculosis*<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Вироблений у клітинах *Lactococcus lactis*

Багатодозовий флакон.

Один флакон (1 мл) містить 10 доз по 0,1 мл.

### Допоміжні речовини з відомим ефектом

Кожна доза (0,1 мл) містить 0,011 мг полісорбату-20. Повний список допоміжних речовин наведено у розділі 6.1.

## 3. ЛІКАРСЬКА ФОРМА

Розчин для ін'єкції (ін'єкційний).

Прозора рідина від безбарвної до блідо-жовтого кольору, рН 7,2 – 7,6.

## 4. КЛІНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 4.1 Терапевтичні показання

SIILTIVCY застосовується як діагностичний засіб для виявлення інфекції *Mycobacterium tuberculosis*, в тому числі викликаного нею захворювання, у дорослих та дітей віком від 28 днів.

Цей лікарський засіб призначений лише для діагностичного використання.

### 4.2 Дозування та спосіб введення

#### Дозування

Одна доза становить 0,1 мл SIILTIVCY.

#### Особливі категорії пацієнтів

*Люди похилого віку*

Є лише обмежені дані щодо безпеки та ефективності застосування SIILTIBCY людям віком 65 років та старше. Немає необхідності змінювати дозування для цієї категорії.

### Діти

Немає даних щодо безпеки та ефективності застосування SIILTIBCY новонародженим дітям віком до 28 днів.

### Спосіб введення

Підготовка та інтрадермальне введення SIILTIBCY здійснюється медичними працівниками, навченими техніці проведення проби Манту. При введенні лікарського засобу слід дотримуватися адекватної гігієни рук із застосуванням асептичних технік, а саме:

- Наберіть 0,1 мл SIILTIBCY за допомогою шприца об'ємом 1 мл із голкою з коротким зрізом. Перед тим як набирати SIILTIBCY із багатодозового флакона, видаліть повітря зі шприца. Якщо флакон уже було відкрито, протріть його спиртовою серветкою та дайте висохнути перед використанням.
- Введіть 0,1 мл SIILTIBCY інтрадермально в середню третину передпліччя за технікою виконання проби Манту. Для цього злегка розтягніть шкіру та тримайте голку отвором догори майже паралельно поверхні шкіри. Введіть кінчик голки в поверхневий шар дерми. Переконайтеся, що під час ін'єкції голку видно через епідерміс. Не застосовуйте тест на ділянках шкіри зі шрамами, висипкою, опіками або татуюванням.
- Повільно введіть набрані 0,1 мл розчину. З'явиться невелика папула білуватого кольору діаметром 8–10 міліметрів (мм), яка повинна зникнути приблизно через 10 хвилин. Якщо папула не з'явилася, повторіть введення 0,1 мл SIILTIBCY на іншій руці або на тій самій руці, але на відстані не менше 4 см від місця першого введення.

### Оцінка реакції

Інтрадермальна ін'єкція SIILTIBCY може спричинити появу ущільнення в місці введення препарату. Ущільнення може виглядати як припіднята ділянка з чітко окресленими краями у місці введення та навколо нього. Хоча ущільнення може супроводжуватися набряком, слід вимірювати лише ущільнення.

Ущільнення вимірюється підготовленим медичним спеціалістом через 48-72 години після ін'єкції. Виміряйте діаметр ущільнення перпендикулярно довгій осі передпліччя за допомогою лінійки. Для зручності вимірювання радимо застосовувати гнучку лінійку (або таку, яка легко згинається).

Зазвичай ущільнення та еритема зменшуються через 4 дні і зникають протягом 28 днів після ін'єкції.

### Інтерпретація результатів

Ущільнення розміром  $\geq 5$  мм вважається позитивним результатом тесту, що свідчить про інфікування *Mycobacterium tuberculosis*.

При інтерпретації результатів шкірного тесту необхідно зважати на спеціальний контекст її застосування та оцінку ризиків. Результати шкірного тесту можна доповнити рентгенограмою та іншими діагностичними оцінками.

При виконанні тесту раніше, ніж через 6-8 тижнів після контакту з *Mycobacterium tuberculosis* результат може бути хибнонегативний.

Ризик хибнопозитивних результатів тесту може зрости при повторному застосуванні SIILTIBCY

протягом 6 тижнів. Тому слід дотримуватися інтервалу не менше 6 тижнів при виконанні повторної туберкулінового шкірного тесту. Це може бути актуальним для учасників програм скринінгу, наприклад, медичних працівників та осіб, які перебували у контакті з хворим на активний туберкульоз (тобто, індексні контакти).

Як і для будь-якого інструменту діагностики, існує вірогідність хибнонегативних результатів (більш детальну інформацію наведено у розділі 5.1). При отриманні негативного результату тесту та за високого рівня клінічної підозри необхідно виконати додаткові обстеження.

Результати тесту не залежать від попередньої вакцинації БЦЖ (*Bacillus Calmette-Guérin*, BCG).

#### **4.3 Протипоказання**

Гіперчутливість до активних компонентів лікарського засобу або до будь-яких допоміжних речовин, перелічених в розділі 6.1. Гіперчутливість до *Lactococcus lactis*.  
Важка місцева або системна реакція на інші продукти, похідні від *Mycobacterium tuberculosis*.

#### **4.4 Особливі застереження та заходи безпеки при застосуванні**

##### Відстежуваність

Задля покращення відстежуваності біологічних лікарських засобів необхідно чітко реєструвати назву препарату, що вводиться, та номер партії.

##### Загальні рекомендації

##### Анафілактична реакція

Після введення SIILTIBCY можлива анафілактична реакція або інші реакції алергічного типу. Необхідно завжди забезпечувати наявність належного обладнання для ведення таких реакцій під час здійснення тесту. Рекомендується ретельно спостерігати за станом пацієнта протягом не менше 15 хвилин після проведення тесту.

##### Шлях введення

Для отримання надійних результатів необхідно дотримуватися техніки виконання проби Манту, отже, слід уникати підшкірного або внутрішньом'язового ввезення.

##### Особливі категорії пацієнтів

Реакція на SIILTIBCY може бути не такою виразною або хибнонегативною у імунокомпроментованих осіб, в тому числі у тих, хто отримує терапію препаратами для імуносупресії та у осіб з вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), якщо кількість CD4-позитивних (CD4+) Т-лімфоцитів (Т-клітин)  $< 100$  Т-клітин/мм<sup>3</sup>. Позитивний результат тесту вказує на інфікування *Mycobacterium tuberculosis* незалежно від кількості CD4+ Т-клітин.

Ризик отримання хибнонегативних результатів зростає у людей похилого віку через вікову імуносенесценцію.

##### Попередній контакт з нетуберкульозними мікобактеріями

SIILTIBCY не виявляє суб'єктів, які раніше контактували з нетуберкульозними мікобактеріями, а також тих, кому було проведено вакцинацію або терапію вакциною БЦЖ, а отже, не слід використовувати лікарський засіб з цією метою.

##### Діагностика активного туберкульозу

SIILTIBCY не можна використовувати як єдиний інструмент для діагностики активного туберкульозу. Для осіб з підозрою на активний туберкульоз слід розглянути проведення оцінки ризиків, радіографічного дослідження та інших діагностичних оглядів та тестів.

#### Допоміжні речовини

Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (39 мг)/дозу калію, тобто практично вільний від калію.

Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг)/дозу натрію, тобто практично вільний від натрію.

Кожна доза цього лікарського засобу містить 0,011 мг полісорбату 20, що еквівалентно 0,11 мг/мл. Полісорбати можуть викликати алергічну реакцію.

#### **4.5 Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші взаємодії**

Дослідження взаємодії не проводилося.

Реакція на тест SIILTIBCY, як і на інші шкірні проби на *Mycobacterium tuberculosis*, може бути зниженою у осіб, які приймають кортикостероїди або засоби для імунної супресії.

Зниження реакції може спостерігатися при використанні SIILTIBCY після вакцинації живими вакцинами (напр., вакцини від кору, паротиту та краснухи). Така знижена реактивність може призвести до хибнонегативного результату. Тому тест SIILTIBCY слід проводити або до вакцинації чи одночасно з нею, або провести пізніше, через 4 тижні після вакцинації.

Позитивний результат тесту вказує на інфікування *Mycobacterium tuberculosis*, незалежно від одночасного застосування інших лікарських засобів.

#### **4.6 Фертильність, вагітність та лактація**

##### Вагітність

Даних щодо використання SIILTIBCY у вагітних жінок немає або вони обмежені.

Дослідження на тваринах не продемонстрували прямого або непрямого шкідливого впливу, пов'язаного з репродуктивною токсичністю (див. розділ 5.3).

Через незначну системну дію SIILTIBCY не очікується, що він впливатиме на протікання вагітності. Використання SIILTIBCY є безпечним.

##### Грудне вигодовування

Через незначний контакт з SIILTIBCY у матерів, що годують грудьми, не очікується, що лікарський засіб матиме вплив на новонароджених / дітей, які вигодовуються грудьми. Проведення шкірних тестів під час грудного вигодовування є безпечним.

##### Фертильність

Досліджень на тваринах для виявлення впливу SIILTIBCY на фертильність не проводилося. Беручи до уваги мінімальну системну дію SIILTIBCY, не очікується, що лікарський засіб матиме вплив на фертильність у чоловіків та жінок.

#### **4.7 Вплив на здатність управляти автотранспортом або працювати з механізмами**

Лікарський засіб SIILTIBCY не впливає або мінімально впливає на здатність управляти автотранспортом або працювати з іншими механізмами.

#### 4.8 Побічні реакції

##### Огляд профілю безпеки

Представлений нижче профіль ґрунтується на даних, отриманих з 7 клінічних досліджень (TESEC-01 - TESEC-07), в яких лікарський засіб SIILTIBCY вводився 2 960 суб'єктам дослідження (віком від 32 днів до 76 років) (Таблиця 1).

Найпоширенішими побічними реакціями були свербіж в місці ін'єкції (20%), біль в місці ін'єкції (8%) та гематома в місці ін'єкції (6%).

##### Табличний перелік побічних реакцій

Зареєстровані побічні реакції класифіковано за частотою їх виникнення: дуже часто ( $\geq 1/10$ ); часто (від  $\geq 1/100$  до  $< 1/10$ ); нечасто (від  $\geq 1/1\,000$  до  $< 1/100$ ); рідко (від  $\geq 1/10\,000$  до  $< 1/1\,000$ ); дуже рідко ( $< 1/10\,000$ ) та невідомо (неможливо оцінити, виходячи з наявних даних). Побічні реакції на препарат об'єднано в класи MedDRA у відповідності до системних органів. В кожній групі за частотою побічні реакції представлено в порядку зменшення їхньої тяжкості.

**Таблиця 1: Зареєстровані побічні реакції на лікарський засіб SIILTIBCY (об'єднані дані за віковими групами немовлята, діти, підлітки та дорослі)**

| Клас системного органу                                        | Частота    | Побічна реакція                 |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| Інфекції та паразитарні інвазії                               | Нечасто    | Гастроентерит                   |
| Розлади кровоносної та лімфатичної системи                    | Нечасто    | Лімфаденопатія                  |
|                                                               | Рідко      | Лімфаденіт                      |
|                                                               |            | Еозинофілія                     |
| Розлади з боку нервової системи                               | Часто      | Головний біль                   |
|                                                               | Нечасто    | Запаморочення                   |
|                                                               | Рідко      | Дискомфорт в області голови     |
|                                                               |            | Парестезія                      |
| Розлади з боку шлунково-кишкового тракту                      | Нечасто    | Діарея                          |
|                                                               |            | Нудота                          |
|                                                               | Рідко      | Блювання                        |
| Розлади з боку печінки та жовчного міхура                     | Рідко      | Гепатит                         |
|                                                               |            | Жовтяниця                       |
|                                                               |            | Збільшені показники трансаміназ |
| Розлади з боку шкіри та підшкірних тканин                     | Нечасто    | Висипка                         |
|                                                               |            | Свербіж                         |
|                                                               | Рідко      | Нічні потіння                   |
|                                                               |            | Кропив'янка                     |
| Розлади з боку м'язово-скелетної системи та сполучної тканини | Нечасто    | Біль в кінцівці                 |
|                                                               | Рідко      | Міалгія                         |
|                                                               |            | Артрит                          |
| Загальні розлади та стани в місці введення препарату          | Дуже часто | Свербіж у місці ін'єкції        |
|                                                               | Часто      | Гематома у місці ін'єкції       |

|                               |                |                                          |
|-------------------------------|----------------|------------------------------------------|
|                               |                | Везикули у місці ін'єкції                |
|                               |                | Ущільнення у місці ін'єкції <sup>#</sup> |
|                               |                | Набряк у місці ін'єкції                  |
|                               |                | Біль у місці ін'єкції                    |
|                               |                | Висипка у місці ін'єкції                 |
|                               |                | Еритема у місці ін'єкції                 |
|                               | Нечасто        | Виразка у місці ін'єкції                 |
| <b>Клас системного органу</b> | <b>Частота</b> | <b>Побічна реакція</b>                   |
|                               |                | Кровотеча у місці ін'єкції               |
|                               |                | Гарячка                                  |
|                               |                | Нездужання                               |
|                               |                | Втома                                    |
|                               |                | Знебарвлення шкіри у місці ін'єкції      |
|                               |                | Біль                                     |
|                               |                | Симптоми, схожі на грип                  |
|                               | Рідко          | Біль у пахвових ділянках                 |
|                               |                | Запалення місця ін'єкції                 |
|                               |                | Кропив'янка у місці ін'єкції             |
|                               |                | Вузлик у місці ін'єкції                  |
|                               |                | Папула у місці ін'єкції                  |
|                               |                | Озноб                                    |
|                               |                | Зменшення чутливості місця ін'єкції      |

#: Більш детальну інформацію див. в «Описі певних побічних реакцій».

#### Опис певних побічних реакцій

##### Реакції в місці ін'єкції

Легкі реакції в місці введення ін'єкції були поширеними, зокрема, свербіж, біль, гематома, висипка, везикули, ущільнення, еритема та набряк. Ущільнення та еритема – це очікувані реакції у осіб, інфікованих *Mycobacterium tuberculosis*. Випадки, коли діаметр ущільнення перевищує 50 мм, а розмір еритреми перевищує 80 мм, не є частими. Побічні реакції в місці введення ін'єкції загалом були транзиторними, їхня тяжкість зазвичай знижувалася протягом 4 днів, а протягом 28 днів реакція зникала.

##### Особливі категорії пацієнтів

Пацієнти з позитивним ВІЛ-статусом на момент скринінгового візиту включалися в клінічні випробування SHLTIBCY, якщо вони приймали антиретровірусну терапію, але виключалися з дослідження у разі, якщо у них було діагностовано синдром набутого імунodefіциту людини (СНІД). Наявні дані свідчать про те, що частота, тип та тяжкість побічних реакцій у групі осіб загалом були такими ж, як в групі загального дорослого населення.

##### Діти

Оцінка безпечності застосування лікарського засобу у дітей та підлітків базується на даних,

отриманих з двох клінічних досліджень Фази 3 – TESEC-05 та TESEC-06, в яких SIILTIBCY було введено загалом 723 дітям у віці від 32 днів до 17 років (див. розділ 5.1). Загалом, результати безпечності застосування лікарського засобу у немовлят, дітей та підлітків були зіставними з результатами, які спостерігалися у групі дорослого населення.

#### Реєстрація підозр на побічні реакції

Важливо реєструвати підозри на побічні реакції після введення лікарського засобу. Це забезпечить безперервний моніторинг балансу переваг/ризиків, пов'язаних із застосуванням лікарського засобу. Просимо медичних спеціалістів звітувати про будь-які підозрювані побічні реакції через національну систему звітності, наведену в [Додатку V](#).

### **4.9 Передозування**

Про випадки передозування не повідомлялося.

## **5. ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ**

### **5.1 Фармакодинаміка**

Фармакотерапевтична група: ще не призначено, АТС-код: ще не призначено.

#### Механізм дії

SIILTIBCY містить два рекомбінованих специфічних антигени *Mycobacterium tuberculosis*: рекомбінований димер раннього секреторного антигенного білка (rdESAT-6) та рекомбінований білок фільтрату культурального середовища (rCFP-10). У випадку інфікування *Mycobacterium tuberculosis* SIILTIBCY індукує реакцію гіперчутливості уповільненого типу, спрямовану цитокінами, які вивільняються Т-хелперами 1-го типу після стимуляції специфічними антигенами, включеними до SIILTIBCY.

Ця реакція виглядає як ущільнення в місці ін'єкції. Це ущільнення збільшується до свого максимального розміру через 48 – 72 години після введення ін'єкції.

#### Клінічна ефективність

Діагностичну ефективність SIILTIBCY для визначення осіб, інфікованих *Mycobacterium tuberculosis*, було оцінено в трьох основних клінічних випробуваннях: TESEC-05, TESEC-06 та TESEC-07 (Таблиця 2, Таблиця 3) у порівнянні з іншими схваленими діагностичними імунологічними тестами на туберкульоз, а саме, очищеним білковим дериватом туберкуліну від Данського інституту сироваток (SSI) (PPD RT 23 SSI, надалі скорочено PPD) та QuantiFERON®-TB Gold in-Tube (QFT).

В ході післядослідного аналізу було проведено оцінку чутливості та специфічності SIILTIBCY та інших діагностичних тестів (QFT та PPD) у популяції для повного аналізу (FAS) з підтвердженням туберкульозом та, відповідно, у групі негативного контролю (Таблиця 2 та Таблиця 3).

#### TESEC-05

Це клінічне випробування Фази 3 порівнювало діагностичну ефективність SIILTIBCY та QFT, у поєднанні з подвійною сліпою рандомізованою спліт-боді оцінкою SIILTIBCY у порівнянні з PPD. Основними завданнями випробування були аналіз ефективності SIILTIBCY в розрізі віку, ВІЛ-статусу та рівня CD4+, а також оцінка клінічної безпечності SIILTIBCY з особливою увагою таким категоріям, як діти та ВІЛ-позитивні особи. Основним результатом був рівень позитивного результату тесту для SIILTIBCY; другорядними результатами були порівняння



рівнів позитивних результатів тестів для SIILTIBCY, PPD та QFT, а також чутливості та специфічності.

Випробування проводилося в Південно-Африканській Республіці, де туберкульоз є ендемічним захворюванням, висока поширеність ВІЛ інфекції, а вакцинація БЦЖ при народженні є рутинною практикою.

У випробування були залучені загалом 1 190 суб'єктів, з яких 1 090 мали підозру на туберкульоз (від 0 до 65 років). Двісті двадцять дев'ять учасників (25.1%) були ВІЛ-позитивними, а 882 (74.1%) були вакциновані БЦЖ. Середній вік (стандартне відхилення [СВ]) учасників дослідження становив 22.5 (18.3), а діапазон – від 1 місяця до 65 років. Розподіл за віком наближався до 50% (49.5% жінки vs 50.5% чоловіки). Група негативного контролю (n = 100) складалася з дітей віком від 5 до 11 років з невідомими даними щодо контакту з особами, інфікованими *Mycobacterium tuberculosis*, та відсутністю ознак туберкульозу.

Суб'єктів випробування було випадковим чином розподілено на групи, яким проводилися подвійні ін'єкції SIILTIBCY та PPD в будь-яке передпліччя (спліт-боді); перед проведенням шкірних тестів були взяті зразки крові для ІГРА-тесту з подальшим порівнянням показників позитивних результатів тестів.

#### TESEC-06

Подвійне сліпе рандомізоване спліт-боді дослідження Фази 3, яке проводилося в 13 центрах в Іспанії, порівнювало діагностичну ефективність SIILTIBCY з діагностичною ефективністю QFT в 4 групах ризику (негативний контроль, випадкові контакти, близькі контакти та позитивний контроль). Основним завданням випробування було оцінити, чи зберігатиметься тенденція позитивності тесту SIILTIBCY зі зростанням ризику інфікування *Mycobacterium tuberculosis* (тобто, від негативного контролю до випадкових та близьких контактів). Другорядними результатами були порівняння позитивності, чутливості та специфічності тестів SIILTIBCY, QFT та PPD.

В дослідженні взяли участь 979 суб'єктів, придатних за критеріями (віком від 0 до 76 років), а саме, 263 негативних контролю, 299 випадкових контактів, 316 близьких контактів та 101 хворий на туберкульоз. Середній (СВ) вік усіх залучених суб'єктів становив 30,6 (14,5) років. Загалом, 53,5% суб'єктів були жіночої та 46,5% - чоловічої статі. Серед усіх суб'єктів дослідження 366 (37,4%) були вакциновані БЦЖ. Усі суб'єкти дослідження в групах випадкових та близьких контактів, а також в групі позитивного контролю отримали подвійні ін'єкції SIILTIBCY та PPD. В групі негативного контролю 213 суб'єктів отримали подвійні ін'єкції SIILTIBCY та PPD в різні руки, а підгрупі з 50 суб'єктів було введено лише SIILTIBCY, щоб визначити, чи вплинуло одночасне введення PPD на реакцію на SIILTIBCY. Для усіх суб'єктів віком від 5 років було заплановано тестування QFT перед проведенням шкірного тесту, щоб уникнути можливих бустерних реакцій.

#### TESEC-07

Це подвійне сліпе рандомізоване контрольоване клінічне дослідження Фази 2/3 серед дорослих з новими випадками активного легеневого туберкульозу, які отримували лікування < 2 тижнів, проводилося у 7 центрах в Південно-Африканській Республіці. Основними завданнями випробування було дослідження та порівняння розмірів ущільнення в місці ін'єкції SIILTIBCY та PPD при введенні окремо або паралельно в різні руки та оцінити, чи впливає одночасне введення SIILTIBCY та PPD на чутливість тестів. Другорядним завданням випробування було порівняння рівнів позитивності (чутливості) тесту SIILTIBCY з рівнями позитивності (чутливості) PPD та QFT.

Було залучено 456 придатних за критеріями дорослих (від 18 до 67 років) та випадковим чином розподілено в одну з трьох груп лікування, в якій суб'єктам вводили або SIILTIBCY (n = 1534), або PPD (n = 149), або SIILTIBCY та PPD (n = 153) в одне з передпліч. До проведення шкірних

тестів були зібрані зразки для тестування QFT.

Середній вік (СВ) у популяції для повного аналізу становив 37,2 (12,7) років в групі SIILTIBCY, 36,3 (11,8) років в групі PPD та 35,3 (11,5) років в групі SIILTIBCY та PPD. Загалом, 64,3% суб'єктів були чоловічої статі, а 35,7% - жіночої.

**Таблиця 2: Аналіз чутливості – окремі клінічні дослідження TESEC-05/-06/-07 (популяції для повного аналізу (FAS) з підтвердженням туберкульозом)**

|                                 | SIILTIBCY |                              | QFT |                              | PPD |                              | Різниця в чутливості, %<br>(95% ДІ) |                        |
|---------------------------------|-----------|------------------------------|-----|------------------------------|-----|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Клініч<br>не<br>дослід<br>ження | n         | Чутливість,<br>%<br>(95% ДІ) | n   | Чутливість,<br>%<br>(95% ДІ) | n   | Чутливість,<br>%<br>(95% ДІ) | SIILTIBCY<br>- QFT                  | SIILTIBCY<br>- PPD     |
| TESEC-05                        | 75        | 72.0<br>(61.8; 82.2)         | 70  | 58.6<br>(47.0; 70.1)         | 75  | 77.3<br>(67.9; 86.8)         | 13.4<br>(-3.3; 30.2)                | -5.3<br>(-20.6; 9.9)   |
| TESEC-06                        | 100       | 68.0<br>(58.9; 77.1)         | 101 | 81.2<br>(73.6; 88.8)         | 100 | 81.0<br>(73.3; 88.7)         | -13.2<br>(-26.1; -0.3)              | -13.0<br>(-25.9; -0.1) |
| TESEC-07                        | 305       | 78.0<br>(73.4; 82.7)         | 446 | 69.5<br>(65.2; 73.8)         | 303 | 87.1<br>(83.4; 90.9)         | 8.5<br>(1.9; 15.1)                  | -9.1<br>(-15.4; -2.8)  |

Скорочення: БЦЖ = бацила Кальметта-Герена; ДІ = довірчий інтервал; FAS = популяція для повного аналізу; ВІЛ = вірус імунодефіциту людини; мм = міліметр; n = кількість суб'єктів в популяції з результатом тесту; PPD = очищений білковий дериват туберкуліну RT 23 SSІ; QFT = тест QuantiFeron®-TB Gold in-Tube. Аналіз чутливості виконувався *post hoc*.

Відсоткові частки розраховувалися з використанням n в знаменнику. Для діагностичного результату тесту SIILTIBCY використовувалося порогове значення  $\geq 15$  мм для ВІЛ-негативних суб'єктів та вакцинованих БЦЖ, та 5 мм для інших. Діагностичний результат тесту QFT базувався на алгоритмі, запропонованому виробником. Невизначені результати QFT були включені в аналіз як “не позитивні” або “не негативні” залежно від того, чи обчислювали чутливість або специфічність QFT, відповідно. Осіб із підозрою на туберкульоз не враховували під час розрахунку чутливості.

**Таблиця 3: Аналіз специфічності – окремі клінічні дослідження TESEC-05/-06/-07 (популяції для повного аналізу (FAS) без туберкульозу)**

|                                 | SIILTIBCY |                              | QFT |                              | PPD |                              | Різниця в специфічності,<br>% (95% ДІ) |                      |
|---------------------------------|-----------|------------------------------|-----|------------------------------|-----|------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Клініч<br>не<br>дослід<br>ження | n         | Чутливість,<br>%<br>(95% ДІ) | n   | Чутливість,<br>%<br>(95% ДІ) | n   | Чутливість,<br>%<br>(95% ДІ) | SIILTIBCY<br>- QFT                     | SIILTIBCY<br>- PPD   |
| TESEC-05                        | 100       | 83.0<br>(75.6; 90.4)         | 98  | 71.4<br>(62.5; 80.4)         | 100 | 85.0<br>(78.0; 92.0)         | 11.6<br>(-1.0; 24.2)                   | -2.0<br>(-13.2; 9.2) |
| TESEC-06                        | 263       | 96.6<br>(94.4; 98.8)         | 263 | 96.2<br>(93.9; 98.5)         | 213 | 93.4<br>(90.1; 96.8)         | 0.4<br>(-3.2; 3.9)                     | 3.2<br>(-1.3; 7.6)   |

Скорочення: БЦЖ = бацила Кальметта-Герена; ДІ = довірчий інтервал; FAS = популяція для повного аналізу; ВІЛ = вірус імунодефіциту людини; мм = міліметр; n = кількість суб'єктів в популяції з результатом тесту; PPD = очищений білковий дериват туберкуліну RT 23 SSІ; QFT = тест QuantiFeron®-TB Gold in-Tube. Аналіз специфічності виконувався *post hoc*. Р Відсоткові частки розраховувалися з використанням n в знаменнику. Для діагностичного результату тесту SIILTIBCY використовувалося порогове значення  $\geq 5$  мм. Для діагностичного результату тесту PPD використовувалося порогове значення  $\geq 15$  мм для ВІЛ-негативних суб'єктів та суб'єктів, вакцинованих БЦЖ, та 5 мм для інших. Діагностичний результат тесту QFT базувався на алгоритмі, запропонованому виробником. Невизначені результати QFT були включені в аналіз як “не позитивні” або “не негативні” залежно від того, чи обчислювали чутливість або специфічність QFT, відповідно. В дослідженні TESEC-07 не оцінювалася специфічність тесту,

оскільки це дослідження проводилося в популяції пацієнтів, яким нещодавно було діагностовано активний туберкульоз.

#### Допоміжний аналіз

З метою оцінки діагностичної ефективності тесту SIILTIBCY було виконано *post hoc* аналіз даних, отриманих з трьох основних клінічних досліджень (TESEC-05, TESEC-06 та TESEC-07). Невизначені результати QFT були включені в аналіз як “не позитивні” або “не негативні” залежно від того, чи обчислювали чутливість або специфічність QFT, відповідно. Суб’єкти з підозрою на туберкульоз не враховувалися при обчисленні чутливості або специфічності тесту.

#### *Чутливість*

Чутливість тесту оцінювалася у суб’єктів досліджень TESEC-05 та TESEC-07, які мали активний туберкульоз, підтверджений культурою. Чутливість тесту SIILTIBCY (n = 380) була 76,8% (95% ДІ: 72,6; 81,1), порівняно з 68,0% (95% ДІ: 64,0; 72,0) для тесту QFT (n = 516) та 85,2% (95% ДІ: 81,6; 88,8) для PPD (n = 378). Відсоткова різниця в чутливості становила 8,8% (95% ДІ: 2,7; 14,9) у порівнянні з QFT та -8,3% (95% ДІ: -14,2; -2,5) у порівнянні з PPD.

#### Особливі категорії пацієнтів

##### *Діти*

В два клінічних дослідження Фази 3 (TESEC-05 та TESEC-06) було включено 723 суб’єкти дитячого віку (від 32 днів до 2 років: 115 суб’єктів; від 2 до 4 років: 156 суб’єктів; від 5 до 11 років: 312 суб’єктів; від 12 до 17 років: 140 суб’єктів) з метою оцінки діагностичної ефективності та безпечності SIILTIBCY у педіатричного населення. Діти отримували таку ж дозу SIILTIBCY, як і дорослі. Вимірювання ущільнення проводилося через 2-3 дні після введення SIILTIBCY, а пороговим значенням для позитивного тесту було  $\geq 5$  мм.

Чутливість та специфічність SIILTIBCY в різних вікових групах оцінювалися в *post hoc* аналізі сукупних даних трьох ключових досліджень (TESEC-05, TESEC-06 та TESEC-07).

У дітей віком від 0 до 10 років чутливість тесту SIILTIBCY (n = 5) становила 80,0% (95% ДІ: 44,9; 100,0), у порівнянні з 66,7% (95% ДІ: 13,3; 100,0) для QFT (n = 3) та 60,0% (95% ДІ: 17,1; 100,0) для PPD (n = 5). У осіб віком від 11 до 25 років чутливість тесту SIILTIBCY (n = 108) становила 81,5% (95% ДІ: 74,2; 88,8), порівняно з 76,3% (95% ДІ: 69,1; 83,5) для QFT (n = 135) та 90% (95% ДІ: 84,1; 95,9) для PPD (n = 100).

У дітей віком від 0 до 10 років специфічність тесту SIILTIBCY (n = 85) становила 81,2% (95% ДІ: 72,9; 89,5), порівняно з 72,3% (95% ДІ: 62,7; 81,9) для QFT (n = 83) та 84,7% (95% ДІ: 77,1; 92,4) для PPD (n = 85). У осіб віком від 11 до 25 років специфічність тесту SIILTIBCY (n = 241) становила 98,3% (95% ДІ: 96,7; 100,0), порівняно з 95,9% (95% ДІ: 93,3; 98,4) для QFT (n = 241) та 97,4% (95% ДІ: 95,1; 99,6) для PPD (n = 191).

## **5.2 Фармакокінетичні властивості**

Не виконувалося дослідження фармакокінетичних властивостей. Оскільки SIILTIBCY вводиться інтрадермально, вплив є переважно місцевим, а очікувана системна дія є дуже незначною.

## **5.3 Доклінічні дані з безпеки**

Неклінічні дані по rdESAT-6 (введеного підшкірно щурам та собакам) та комбінації rdESAT-6 + rCFP-10 (введеної підшкірно щурам) не вказують на особливу небезпеку для людини на підставі стандартних досліджень гострої та повторної токсичності.

Дослідження впливу комбінації rdESAT-6 + rCFP-10 та носія фенолу в концентрації 0,5% (який входить до складу комерційної форми препарату), яку вводили підшкірно щурам, на

ембріофетальний розвиток, не виявили токсичного впливу на організм матері або ембріофетальних аномалій розвитку. Розрахункова доза для людей, еквівалентна тій, при якій у шурів не спостерігалось ефекту, становила 4,64 мкг/кг rdESAT-6 + rCFP-10 (більш ніж в 2 700 разів вища за людську дозу) в дослідженнях токсичності повторних доз, та 6,08 мкг/кг для комбінації rdESAT-6 + CFP-10 в дослідженні ембріофетального розвитку (більш ніж у 3 500 разів вища за людську дозу).

## **6. ФАРМАЦЕВТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ**

### **6.1 Список допоміжних речовин**

Динатрій гідрофосфат дигідрат (E339)  
Калій дигідроген ортофосфат (E340)  
Хлорид калію (E508)  
Хлорид натрію  
Полісорбат 20 (E432)  
Фенол  
Вода для ін'єкцій

### **6.2 Несумісності**

Через відсутність досліджень сумісності цей лікарський засіб не дозволяється змішувати з іншими продуктами.

### **6.3 Термін придатності**

Лікарський засіб в закритій заводській упаковці

до 31 серпня 2028 року

Після першого відкриття флакону

Приготовлений препарат продемонстрував хімічну та фізичну стабільність після зберігання протягом 28 днів при температурі від 2°C до 8°C.

З точки зору мікробіології, препарат повинен зберігатися не довше 28 днів після відкриття при температурі від 2°C до 8°C. Інші строки та умови зберігання приготовленого препарату до його застосування є відповідальністю користувача.

### **6.4 Особливі застереження щодо зберігання**

Зберігати в холодильнику (2°C – 8°C). Не заморозувати.  
Зберігати в заводській упаковці для захисту від світла.

Умови зберігання лікарського засобу після першого відкриття див. у розділі 6.3.

### **6.5 Характер та вміст упаковки**

1 мл розчину у багатодозовому прозорому скляному флаконі з пробкою (бромобутилкаучук) та пластиковим ковпачком фліп-офф з алюмінієвою обкаткою. Кожен флакон містить 10 доз 0,1 мл.

Розміри упаковки

- 1 багатодозовий флакон

- Мультипак, що містить 10 (10 упаковок по 1) багатодозових флаконів.

На ринку можуть бути представлені не всі розміри упаковок.

#### **6.6 Особливі застереження щодо утилізації та поводження**

Після виписки слід проінструктувати пацієнтів про необхідність тримати місце ін'єкції в чистоті. Слід уникати чухання місця ін'єкції, однак у випадку свербіння можна прикласти холодний компрес.

Усі невикористані залишки лікарського засобу або відходи необхідно утилізувати у відповідності до місцевих вимог.

Розчин необхідно утилізувати при появі видимих часток.

#### **7. ВЛАСНИК ДОЗВОЛУ НА МАРКЕТИНГ**

Serum Life Science Europe GmbH  
Ahrensburger Strasse 1  
30659 ГанOVER  
Німеччина

#### **8. НОМЕРИ ДОЗВОЛУ НА МАРКЕТИНГ**

EU/1/24/1882/001  
EU/1/24/1882/002

#### **9. ДАТА ПЕРШОЇ ВИДАЧІ / ОНОВЛЕННЯ ДОЗВОЛУ НА МАРКЕТИНГ**

Дата першої видачі дозволу на маркетинг: 13 січня 2025 р.

#### **10. ДАТА ПЕРЕГЛЯДУ ТЕКСТУ**

Детальна інформація про цей лікарський засіб доступна на вебсайті Європейської агенції з лікарських засобів <https://www.ema.europa.eu>.

## **ДОДАТОК II**

- A. ВИРОБНИК БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН  
ТА ВИРОБНИК, ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК  
ПАРТІЇ**
- B. УМОВИ АБО ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ПОСТАЧАННЯ ТА  
ЗАСТОСУВАННЯ**
- C. ІНШІ УМОВИ ТА ВИМОГИ ДОЗВОЛУ НА  
МАРКЕТИНГ**
- D. УМОВИ АБО ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОГО  
ТА ЕФЕКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ  
ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ**

**A. ВИРОБНИК БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ТА ВИРОБНИК,  
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК ПАРТІЇ**

Назва та адреса виробника біологічно активних речовин

Serum Institute of India Pvt. Ltd.  
212/2 Off Soli Poonawalla Road  
Hadapsar  
Pune-411028  
Індія

Назва та адреса виробника, відповідального за випуск партії

Bilthoven Biologicals B.V.  
Antonie Van Leeuwenhoeklaan 9  
3721 MA Bilthoven  
Нідерланди

**B. УМОВИ АБО ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ПОСТАЧАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ**

Лікарський засіб відпускається за рецептом лікаря.

**C. ІНШІ УМОВИ ТА ВИМОГИ ДОЗВОЛУ НА МАРКЕТИНГ**

• **Періодичний звіт про безпеку лікарського засобу (PSUR)**

Вимоги до подачі PSUR по цьому лікарському засобу викладені в Європейському довіднику даних про безпеку (EURD) згідно Статті 107с(7) Директиви 2001/83/ЕС та усіх подальших оновлень цього положення, опублікованих на Європейському веб-порталі лікарських засобів.

Власник дозволу на маркетинг повинен надати перший PSUR для цього продукту протягом 6 місяців після отримання дозволу на маркетинг лікарського засобу.

**D. УМОВИ АБО ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОГО ТА ЕФЕКТИВНОГО  
ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ**

• **План управління ризиками (ПУР)**

Власник дозволу на маркетинг лікарського засобу повинен виконати заходи та втручання з фармаконагляду, детально описані в погодженому ПУР, представленому в Модулі 1.8.2 дозволу на маркетинг лікарського засобу, та в усіх подальших погоджених оновленнях ПУР.

Оновлений ПУР повинен бути наданий:

- На запит Європейської агенції з лікарських засобів;
- При внесенні змін до системи управління ризику, особливо тих, які відбулися в результаті отримання нової інформації та можуть призвести до значних змін співвідношення ризиків та переваг або в результаті досягнення важливого (фармаконагляд або мінімізація ризиків) етапу.

**ДОДАТОК III**  
**МАРКУВАННЯ ТА ЛИСТОК-ВКЛАДИШ**



## **A. МАРКУВАННЯ**

**ВІДОМОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ЗАЗНАЧЕНІ НА ЗОВНІШНІЙ УПАКОВЦІ**  
**ЗОВНІШНЯ КАРТОННА КОРОБКА**

**1. НАЗВА ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ**

SHLTIBCY (0,5 мікрограма + 0,5 мікрограма)/мл розчину для ін'єкцій  
Антигени, отримані з *Mycobacterium tuberculosis* (rdESAT-6 та rCFP-10)

**2. ВІДОМОСТІ ПРО ДІЮЧУ РЕЧОВИНУ**

Одна доза (0,1 мл) містить:

rdESAT-6: 0,05 мікрограма

rCFP-10: 0,05 мікрограма

Кожен флакон (1 мл) містить 10 доз по 0,1 мл.

**3. СПИСОК ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН**

Допоміжні речовини: Динатрій гідрофосфат дигідрат, калій дигідроген ортофосфат, хлорид калію, хлорид натрію, полісорбат 20, фенол, вода для ін'єкцій. Додаткову інформацію див. у листку-вкладиші.

**4. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА ТА ВМІСТ**

Розчин для ін'єкцій

1 багатодозовий флакон (10 доз по 0,1 мл)

**5. СПОСІБ ТА ШЛЯХ(И) ВВЕДЕННЯ**

Для інтрадермального використання.

Перед використанням прочитайте листок-вкладиш.

**6. ОСОБЛИВЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ТЕ, ЩО ЦЕЙ ПРОДУКТ ПОВИНЕН  
ЗБЕРІГАТИСЯ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ**

Зберігати в недоступному для дітей місці.

**7. ІНШІ ОСОБЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, ЯКЩО НЕОБХІДНО**

**8. ДАТА ЗАВЕРШЕННЯ ТЕРМІНУ ПРИДАТНОСТІ**

Придатний до

**9. ОСОБЛИВІ УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ**

Зберігати в холодильнику.

Не заморозувати.

Зберігати в заводській упаковці для захисту від світла.

Після першого відкриття флакону зберігати в холодильнику, використати протягом 28 днів.

**10. ОСОБЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ НЕВИКОРИСТАНОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ АБО ВІДХОДІВ, ПОХІДНИХ ВІД ТАКОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ, ЯКЩО ЗАСТОСОВНО****11. НАЗВА ТА АДРЕСА ВЛАСНИКА ДОЗВОЛУ НА МАРКЕТИНГ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ**

Serum Life Science Europe GmbH  
Ahrensburger Strasse 1  
30659 Hannover  
Німеччина

**12. НОМЕР(И) ДОЗВОЛУ НА МАРКЕТИНГ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ**

EU/1/24/1882/001      1 багатодозовий флакон (10 доз)

**13. НОМЕР ПАРТІЇ**

Партія

**14. ЗАГАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ДЛЯ ПОСТАЧАННЯ****15. ІНСТРУКЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ****16. ІНФОРМАЦІЯ ШРИФТОМ БРАЙЛЯ**

Обґрунтування відсутності інформації шрифтом Брайля прийнято.

**17. УНІКАЛЬНИЙ ІДЕНТИФІКАТОР – 2D ШТРИХКОД**

Додано 2D штрихкод з унікальним ідентифікатором.

**18. УНІКАЛЬНИЙ ІДЕНТИФІКАТОР – ДАНІ У ФОРМАТІ ДЛЯ ЧИТАННЯ ЛЮДИНОЮ**

PC  
SN  
NN

**МІНІМАЛЬНІ ВІДОМОСТІ, ЯКІ ПОВИННІ БУТИ НАНЕСЕНІ НА МАЛИХ ПЕРВИННИХ УПАКОВКАХ**

**ЕТИКЕТКА НА ФЛАКОНІ**

**1. НАЗВА ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ТА ШЛЯХ(И) ВВЕДЕННЯ**

SILTIVCY (0,5 мкг + 0,5 мкг)/мл ін'єкції  
rdESAT-6 / rCFP-10  
Для інтрадермального використання.

**2. СПОСІБ ВВЕДЕННЯ**

**3. ДАТА ЗАВЕРШЕННЯ ТЕРМІНУ ПРИДАТНОСТІ**

Придатний до

**4. НОМЕР ПАРТІЇ**

Партія

**5. ВМІСТ ЗА МАСОЮ, ЗА ОБ'ЄМОМ АБО В ОДИНИЦЯХ**

Багатодозовий флакон об'ємом 1 мл (10 доз по 0,1 мл)

**6. ІНШЕ**

Після відкриття флакону зберігати в холодильнику, використати протягом 28 днів.  
Дата утилізації:

**ВІДОМОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ЗАЗНАЧЕНІ НА ЗОВНІШНІЙ УПАКОВЦІ**  
**ЗОВНІШНЯ КАРТОННА КОРОБКА (МУЛЬТИПАК – ІЗ СИНІМ ПОЛЕМ)**

**1. НАЗВА ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ**

SHLTIBCY (0,5 мікрограма + 0,5 мікрограма)/мл розчину для ін'єкції  
Антигени, отримані з *Mycobacterium tuberculosis* (rdESAT-6 та rCFP-10)

**2. ВІДОМОСТІ ПРО ДІЮЧУ РЕЧОВИНУ**

Одна доза (0,1 мл) містить:

rdESAT-6: 0,05 мікрограма

rCFP-10: 0,05 мікрограма

Кожен флакон (1 мл) містить 10 доз по 0,1 мл.

**3. СПИСОК ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН**

Допоміжні речовини: Динатрій гідрофосфат дигідрат, калій дигідроген ортофосфат, хлорид калію, хлорид натрію, полісорбат 20, фенол, вода для ін'єкцій. Додаткову інформацію див. у листку-вкладиші.

**4. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА ТА ВМІСТ**

Розчин для ін'єкцій

Мультипак: 10 (10 упаковок по 1) багатодозових флаконів.

Кожен флакон містить 10 доз по 0,1 мл

**5. СПОСІБ ТА ШЛЯХ(И) ВВЕДЕННЯ**

Для інтрадермального використання.

Перед використанням прочитайте листок-вкладиш.

**6. ОСОБЛИВЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ТЕ, ЩО ЦЕЙ ПРОДУКТ ПОВИНЕН ЗБЕРІГАТИСЯ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ**

Зберігати в недоступному для дітей місці.

**7. ІНШІ ОСОБЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, ЯКЩО НЕОБХІДНО**

**8. ДАТА ЗАВЕРШЕННЯ ТЕРМІНУ ПРИДАТНОСТІ**

Придатний до

**9. ОСОБЛИВІ УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ**

Зберігати в холодильнику.

Не заморозувати.

Зберігати в заводській упаковці для захисту від світла.

Після першого відкриття флакону зберігати в холодильнику, використати протягом 28 днів.

**10. ОСОБЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ НЕВИКОРИСТАНОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ АБО ВІДХОДІВ, ПОХІДНИХ ВІД ТАКОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ, ЯКЩО ЗАСТОСОВНО****11. НАЗВА ТА АДРЕСА ВЛАСНИКА ДОЗВОЛУ НА МАРКЕТИНГ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ**

Serum Life Science Europe GmbH  
Ahrensburger Strasse 1  
30659 Hannover  
Німеччина

**12. НОМЕР(И) ДОЗВОЛУ НА МАРКЕТИНГ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ**

EU/1/24/1882/002      10 (10 x 1) багатодозових флаконів (мультипак) (100 доз)

**13. НОМЕР ПАРТІЇ**

Партія

**14. ЗАГАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ДЛЯ ПОСТАЧАННЯ****15. ІНСТРУКЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ****16. ІНФОРМАЦІЯ ШРИФТОМ БРАЙЛЯ**

Обґрунтування відсутності інформації шрифтом Брайля прийнято.

**17. УНІКАЛЬНИЙ ІДЕНТИФІКАТОР – 2D ШТРИХКОД**

Додано 2D штрихкод з унікальним ідентифікатором.

**18. УНІКАЛЬНИЙ ІДЕНТИФІКАТОР – ДАНІ У ФОРМАТІ ДЛЯ ЧИТАННЯ ЛЮДИНОЮ**

PC  
SN  
NN

**ВІДОМОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ЗАЗНАЧЕНІ НА ЗОВНІШНІЙ УПАКОВЦІ**  
**КАРТОННА УПАКОВКА ФЛАКОНУ (МУЛЬТИПАК – БЕЗ СИНЬОГО ПОЛЯ)**

**1. НАЗВА ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ**

SILTIVCY (0,5 мікрограма + 0,5 мікрограма)/мл розчину для ін'єкції  
Антигени, отримані з *Mycobacterium tuberculosis* (rdSAT-6 та rCFP-10)

**2. ВІДОМОСТІ ПРО ДІЮЧУ РЕЧОВИНУ**

Одна доза (0,1 мл) містить:

rdSAT-6: 0,05 мікрограма

rCFP-10: 0,05 мікрограма

Кожен флакон (1 мл) містить 10 доз по 0,1 мл.

**3. СПИСОК ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН**

Допоміжні речовини: Динатрій гідрофосфат дигідрат, калій дигідроген ортофосфат, хлорид калію, хлорид натрію, полісорбат 20, фенол, вода для ін'єкцій. Додаткову інформацію див. у листку-вкладиші.

**4. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА ТА ВМІСТ**

Розчин для ін'єкцій

1 багатодозовий флакон (10 доз по 0,1 мл).

Частина мультипаку, не для окремого продажу.

**5. СПОСІБ ТА ШЛЯХ(И) ВВЕДЕННЯ**

Для інтрадермального використання.

Перед використанням прочитайте листок-вкладиш.

**6. ОСОБЛИВЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ТЕ, ЩО ЦЕЙ ПРОДУКТ ПОВИНЕН**  
**ЗБЕРІГАТИСЯ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ**

Зберігати в недоступному для дітей місці.

**7. ІНШІ ОСОБЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, ЯКЩО НЕОБХІДНО**

**8. ДАТА ЗАВЕРШЕННЯ ТЕРМІНУ ПРИДАТНОСТІ**

Придатний до

**9. ОСОБЛИВІ УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ**

Зберігати в холодильнику.

Не заморожувати.

Зберігати в заводській упаковці для захисту від світла.

Після першого відкриття флакону зберігати в холодильнику, використати протягом 28 днів.

**10. ОСОБЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ НЕВИКОРИСТАНОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ АБО ВІДХОДІВ, ПОХІДНИХ ВІД ТАКОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ, ЯКЩО ЗАСТОСОВНО****11. НАЗВА ТА АДРЕСА ВЛАСНИКА ДОЗВОЛУ НА МАРКЕТИНГ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ АБО ВІДХОДІВ, ПОХІДНИХ ВІД ТАКОГО**

Serum Life Science Europe GmbH  
Ahrensburger Strasse 1  
30659 Hannover  
Німеччина

**12. НОМЕР(И) ДОЗВОЛУ НА МАРКЕТИНГ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ**

EU/1/24/1882/002      10 (10 x 1) багатодозових флаконів (мультипак) (100 доз)

**13. НОМЕР ПАРТІЇ**

Партія

**14. ЗАГАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ДЛЯ ПОСТАЧАННЯ****15. ІНСТРУКЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ****16. ІНФОРМАЦІЯ ШРИФТОМ БРАЙЛЯ**

Обґрунтування відсутності інформації шрифтом Брайля прийнято.

**17. УНІКАЛЬНИЙ ІДЕНТИФІКАТОР – 2D ШТРИХКОД****18. УНІКАЛЬНИЙ ІДЕНТИФІКАТОР – ДАНІ У ФОРМАТІ ДЛЯ ЧИТАННЯ ЛЮДИНОЮ**



## **В. ЛИСТОК-ВКЛАДИШ**

## Листок-вкладиш: Інформація для користувача

### **SIILTIBCY (0,5 мікрограма + 0,5 мікрограма)/мл розчину для ін'єкції**

Антигени, отримані з *Mycobacterium tuberculosis* (rdESAT-6 та rCFP-10)

▼ Цей лікарський засіб підлягає додатковому моніторингу, що прискорить виявлення нової інформації про його безпеку. Ви можете допомогти, повідомивши про будь-які побічні ефекти, які можуть виникнути. Остання частина розділу 4 містить інформацію про те, як повідомляти про побічні ефекти.

**Прочитайте уважно листок-вкладиш повністю перед тим, як вам буде проведено шкірний тест, оскільки він містить важливу інформацію для вас.**

- Збережіть цей листок-вкладиш, оскільки вам може знадобитися перерхитати його ще раз.
- Якщо у вас є якісь питання, проконсультуйтеся з вашим лікарем, фармацевтом або медсестрою.
- Якщо ви відчуваєте побічні реакції, проконсультуйтеся з вашим лікарем, фармацевтом або медсестрою, навіть якщо ці побічні ефекти не вказані в цьому листку-вкладиші. Див. розділ 4.

**Яка інформація міститься в цьому листку-вкладиші**

1. Що таке SIILTIBCY та для чого він використовується
2. Про що вам необхідно знати перед проведенням SIILTIBCY
3. Як вводиться SIILTIBCY
4. Можливі побічні реакції
5. Як зберігати SIILTIBCY
6. Вміст упаковки та інша інформація

#### **1. Що таке SIILTIBCY та для чого він використовується**

SIILTIBCY призначений для діагностичного використання і містить два активні компоненти – туберкульоз-специфічні білки (антигени), які називаються rdESAT-6 і rCFP-10.

SIILTIBCY вводиться в шкіру (інтрадермально) для виявлення інфекції (а також захворювання), викликаной *Mycobacterium tuberculosis* у дорослих та дітей віком від 28 днів.

Трактування результатів тесту відбувається в поєднанні з іншими медичними процедурами. Якщо людина була інфікована *Mycobacterium tuberculosis*, її імунна система відреагує виробленням цитокінів (білків запалення), що спричинить ущільнення (затвердіння) в місці на шкірі, куди була зроблена ін'єкція SIILTIBCY. Зазвичай це трапляється протягом 48-72 годин після ін'єкції.

#### **2. Про що вам необхідно знати перед проведенням SIILTIBCY**

**Вам не слід проводити SIILTIBCY**

- якщо у вас є алергія на активні компоненти SIILTIBCY, rdESAT-6, rCFP-10 або будь-які інші компоненти цього лікарського засобу (перелічені у розділі 6).
- якщо у вас є алергія на *Lactococcus lactis* – бактерію, яка використовувалася для виробництва SIILTIBCY.
- якщо у вас колись була тяжка місцева (на шкірі) або загальна (в будь-якому органі тіла) реакція на інші шкірні проби на туберкульоз.

### **Попередження та застереження**

Поговоріть з лікарем, фармацевтом або медсестрою перед проведенням тесту SIILTIBCY, якщо:

- вам уже робили тест SIILTIBCY протягом останніх 6 тижнів.
- протягом останніх 4 тижнів ви були вакциновані живими вакцинами (наприклад, вакцини від кору, паротиту та краснухи).
- ви приймаєте препарати (наприклад, кортикостероїди) або у вас є захворювання, які можуть пригнічувати імунну систему, наприклад, вірус імунодефіциту людини (ВІЛ).

Хоча даних про появу тяжких алергічних реакцій при застосуванні SIILTIBCY немає, у дуже рідкісних випадках спостерігалися тяжкі алергічні реакції (анафілактична реакція) при проведенні інших шкірних проб на туберкульоз. Якщо ви відчуваєте будь-які з цих симптомів після застосування SIILTIBCY, негайно проінформуйте про це лікаря або медсестру, які проводили тест, або зверніться до найближчої клініки або відділення екстреної медичної допомоги.

### **Діти та підлітки**

Немає додаткових застережень або попереджень при застосуванні лікарського засобу у дітей або підлітків.

### **Інші типи мікобактерій (нетуберкульозні мікобактерії) та SIILTIBCY**

SIILTIBCY не призначений для виявлення інфікування типами мікобактерій, які не викликають туберкульоз, або для визначення факту попередньої вакцинації бацилою Кальметта-Герена (БЦЖ).

### **Вагітність, грудне вигодовування та фертильність**

Якщо ви вагітна або годуйте грудьми, підозрюєте у себе вагітність або плануєте дитину, проконсультуйтеся з вашим лікарем або фармацевтом перед виконанням шкірного тесту.

Не очікується, що проведення тесту SIILTIBCY під час вагітності та лактації матиме певний шкідливий вплив.

### **Управління автомобілем та робота з механізмами**

Вплив SIILTIBCY на вашу здатність управляти автомобілем або працювати з механізмами відсутній або незначний.

### **SIILTIBCY містить калій, натрій та полісорбат 20**

Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (39 мг)/дозу калію, тобто практично вільний від калію.

Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг)/дозу натрію, тобто практично вільний від натрію.

Кожна доза цього лікарського засобу містить 0,011 мг полісорбату 20, що еквівалентно 0,11 мг/мл. Полісорбати можуть викликати алергічну реакцію. Проінформуйте вашого лікаря, якщо вам відомо про наявність у вас алергій.

## **3. Як вводиться SIILTIBCY**

Лікар або медсестра введуть SIILTIBCY в верхній шар шкіри на вашій руці. Рекомендована доза становить 0,1 мл. Вона однакова для усіх вікових груп.

Після ін'єкції на шкірі з'явиться папула (бугорок) діаметром 8-10 міліметрів, яка залишатиметься протягом приблизно 10 хвилин. В місці ін'єкції можуть з'явитися почервоніння та ущільнення (затвердіння шкіри). Після ін'єкції лікар або медсестра можуть спостерігати за вами протягом щонайменше 15 хвилин, щоб простежити за появою ознак алергічної реакції.

Тримайте місце ін'єкції в чистоті; не чухайте місце ін'єкції, а у випадку свербіння можна прикласти холодний компрес.

**Ви повинні ще раз прийти до лікаря або медсестри через 48-72 години для перевірки**

**результатів тесту. Якщо з'явилося почервоніння або ущільнення, воно повинне зменшитися після цього часу.**

Detailed information on the method of administration of SIILTIBCY and of evaluation of the result is included in the section "The following information is intended for medical or healthcare professionals only".

SIILTIBCY testing is not influenced by previous vaccination with Bacillus Calmette-Guérin (BCG) vaccine.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor, pharmacist or nurse. Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

### **Важкі побічні реакції**

Хоча даних про появу тяжких алергічних реакцій при застосуванні SIILTIBCY немає, при проведенні інших шкірних проб на туберкульоз у дуже рідкісних випадках спостерігалися тяжкі алергічні реакції (анафілактична реакція), такі як набряк губ, обличчя та гортані, утруднене дихання та кропив'янка. Якщо ви відчуваєте будь-які з цих симптомів після застосування SIILTIBCY, негайно проінформуйте про це лікаря або медсестру, які проводили тест, або зверніться до найближчої клініки або відділення екстреної медичної допомоги.

### **Інші побічні реакції**

**Дуже часті** (можуть виникати більш ніж у 1 з 10 осіб)

- Свербіння в місці ін'єкції

**Поширені** (можуть виникати менш у ніж 1 з 10 осіб)

- Гематома (синець) в місці ін'єкції
- Везикули (прищики) в місці ін'єкції
- Головний біль
- Ущільнення (затвердіння шкіри) в місці ін'єкції
- Набряк в місці ін'єкції
- Біль в місці ін'єкції
- Висипка в місці ін'єкції
- Еритрема (почервоніння) в місці ін'єкції

**Нечасті** (можуть виникати менш ніж у 1 з 100 осіб)

- Лімфаденопатія (набряк лімфатичних вузлів)
- Лихоманка
- Виразки в місці ін'єкції
- Кровотеча в місці ін'єкції
- Нездужання (загальне відчуття дискомфорту, нездужання, поганого самопочуття)
- Головокружіння
- Висипка
- Свербіж
- Міалгія (біль у м'язах)
- Втома
- Знебарвлення (втрата кольору) шкіри в місці ін'єкції
- Біль у кінцівках (кистях, руках, ступнях чи ногах)
- Біль
- Гастроентерит (запалення шлунку та кишківника)
- Діарея
- Грипозний стан
- Нудота

**Рідко** (можуть виникати менш ніж у 1 з 1 000 осіб)

- Лімфаденіт (інфекція лімфатичних вузлів)
- Гепатит (запалення печінки)
- Кропив'янка (набряклі ділянки шкіри, які сверблять) будь-де на тілі
- Біль в пахвовій западині
- Відчуття дискомфорту в голові
- Озноб
- Втрата чутливості (заніміння) в місці ін'єкції
- Папула (бугорок) в місці ін'єкції
- Кропив'янка (набряклі ділянки шкіри, які сверблять) в місці ін'єкції
- Вузлики (припухлість) в місці ін'єкції
- Запалення в місці ін'єкції
- Еозинофілія (зростання рівня білих кров'яних тілець)
- Нічна пітливість
- Артрит (біль та набряки суглобів)
- Блювання
- Збільшення рівня трансаміназ (збільшення рівня ензимів печінки в крові)
- Парестезія (заніміння, відчуття поколювання або лоскотання) в будь-якій ділянці тіла
- Жовтяниця (пожовтіння шкіри та очей)

#### **Як повідомляти про побічні реакції**

Якщо у вас виникнуть будь-які побічні реакції, поговоріть з вашим лікарем, фармацевтом або медсестрою. Це стосується усіх можливих побічних реакцій, не згаданих в цьому вкладиші. Також ви можете повідомити про побічні реакції напряму через національну систему звітності, наведену Ваше повідомлення про побічні реакції допоможе нам зібрати більше інформації про безпечність цього лікарського засобу.

#### **4. Як зберігати SIILTIBCY**

Зберігайте цей лікарський засіб у місці, недоступному для дітей.

Не використовуйте цей лікарський засіб після закінчення терміну придатності, вказаного на картонній упаковці та на етикетці флакона після ПРИДАТНИЙ ДО. Термін придатності - останній день вказаного місяця.

Тримайте лікарський засіб в холодильнику (при температурі від 2°C до 8°C). Не заморозуйте.

Зберігайте лікарський засіб в заводській упаковці, щоб захистити від світла.

Після відкриття флакон можна використовувати протягом 28 днів, якщо зберігати його в холодильнику (при температурі від 2°C до 8°C).

Лікарські засоби не слід викидати в каналізацію. Спитайте в вашого фармацевта, як позбутися лікарських засобів, які ви вже не використовуєте. Це допоможе захистити довкілля.

#### **5. Вміст упаковки та інша інформація**

##### **Що міститься в SIILTIBCY**

- Діючі речовини – це антигени rdESAT-6 та rCFP-10, отримані з *Mycobacterium tuberculosis*.  
Одна доза (0,1 мл) SIILTIBCY містить 0,05 мікрограма rdESAT-6 та 0,05 мікрограма rCFP-10.  
Інші складові – це динатрій гідрофосфат дигідрат (E339), калій дигідрофосфат (E340), хлорид калію (E508), хлорид натрію, полісорбат 20 (E432), фенол та вода для ін'єкцій. Див. розділ 2 «SIILTIBCY містить калій, натрій та полісорбат 20».

**Як виглядає SIILTIBCY та вміст упаковки**

Розчин для ін'єкції SIILTIBCY (ін'єкція) – це прозорий розчин від безбарвного до блідо-жовтого кольору. Не слід використовувати цей лікарський засіб при наявності видимих твердих часток.

SIILTIBCY доступний в упаковках по одному скляному багатодозовому флакону або в мультипаках по 10 (10 упаковок по 1) скляних багатодозових флаконів об'ємом 1 мл кожен.

Не всі розміри упаковок можуть бути представлені на ринку.

**Власник дозволу на маркетинг лікарського засобу**

Serum Life Science Europe GmbH  
Ahrensburger Strasse 1  
30659 Hannover  
Німеччина

**Виробник**

Bilthoven Biologicals B.V.  
Antonie Van Leeuwenhoeklaan 9  
3721 MA Bilthoven  
Нідерланди

**Останню редакцію листка-вкладиша було здійснено у**

Детальна інформація про цей лікарський засіб доступна на веб-сайті Європейської агенції з лікарських засобів: <https://www.ema.europa.eu>.

---

**Наведена нижче інформація призначена лише для медичних працівників**

Підготовка та інтрадермальне введення SIILTIBCY здійснюється медичними працівниками, навченими техніці проведення проби Манту. При введенні лікарського засобу слід дотримуватися адекватної гігієни рук із застосуванням асептичних технік, а саме:

- Наберіть 0,1 мл SIILTIBCY за допомогою шприца об'ємом 1 мл із голкою з коротким зрізом. Перед тим як набирати SIILTIBCY із багатодозового флакона, видаліть повітря зі шприца. Якщо флакон уже було відкрито, протріть його спиртовою серветкою та дайте висохнути перед використанням.
- Введіть 0,1 мл SIILTIBCY інтрадермально в середню третину передпліччя за технікою виконання проби Манту. Для цього злегка розтягніть шкіру та тримайте голку отвором догори майже паралельно поверхні шкіри. Введіть кінчик голки в поверхневий шар дерми. Переконайтеся, що під час ін'єкції голку видно через епідерміс. Не застосовуйте тест на ділянках шкіри зі шрамами, висипкою, опіками або татуюванням.
- Повільно введіть набрані 0,1 мл розчину. З'явиться невелика папула білуватого кольору діаметром 8–10 міліметрів (мм), яка повинна зникнути приблизно через 10 хвилин. Якщо папула не з'явилася, повторіть введення 0,1 мл SIILTIBCY на іншій руці або на тій самій руці, але на відстані не менше 4 см від місця першого введення.

Рекомендовано ретельне спостереження за пацієнтом протягом не менш ніж 15 хвилин після виконання тесту.

**Оцінка реакції**

Інтрадермальна ін'єкція SIILTIBCY може спричинити появу ущільнення в місці введення препарату. Ущільнення може виглядати як припіднята ділянка з чітко окресленими краями у місці введення та навколо нього. Хоча ущільнення може супроводжуватися набряком, слід вимірювати

лише ущільнення.

Ущільнення вимірюється через 48-72 години після ін'єкції. Виміряйте діаметр ущільнення перпендикулярно довгій осі передпліччя за допомогою лінійки. Для зручності вимірювання радимо застосовувати гнучку лінійку (або таку, яка легко згинається).

Зазвичай ущільнення та еритема зменшуються через 4 дні і зникають протягом 28 днів після ін'єкції.

#### *Інтерпретація результатів*

Ущільнення розміром  $\geq 5$  мм вважається позитивним результатом тесту, що свідчить про інфікування *Mycobacterium tuberculosis*.